

# Περίπτωση 30η

Ασθενής 60 ετών με ιστορικό ΧΑΠ υπό οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον και πνευμονικής καρδιάς προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με θωρακαλγία και υπόταση.

- (FiO<sub>2</sub> 21%)
- PO<sub>2</sub> = 45 mmHg
- PCO<sub>2</sub> = 57 mmHg
- pH = 7.38
- [HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>] = 33 mEq/L
- [Na<sup>+</sup>] = 134 mEq/L
- [K<sup>+</sup>] = 3.7 mEq/L
- [Cl<sup>-</sup>] = 98 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 104 mg/dl
- [Ουρίας] = 60 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.2 mg/dl

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

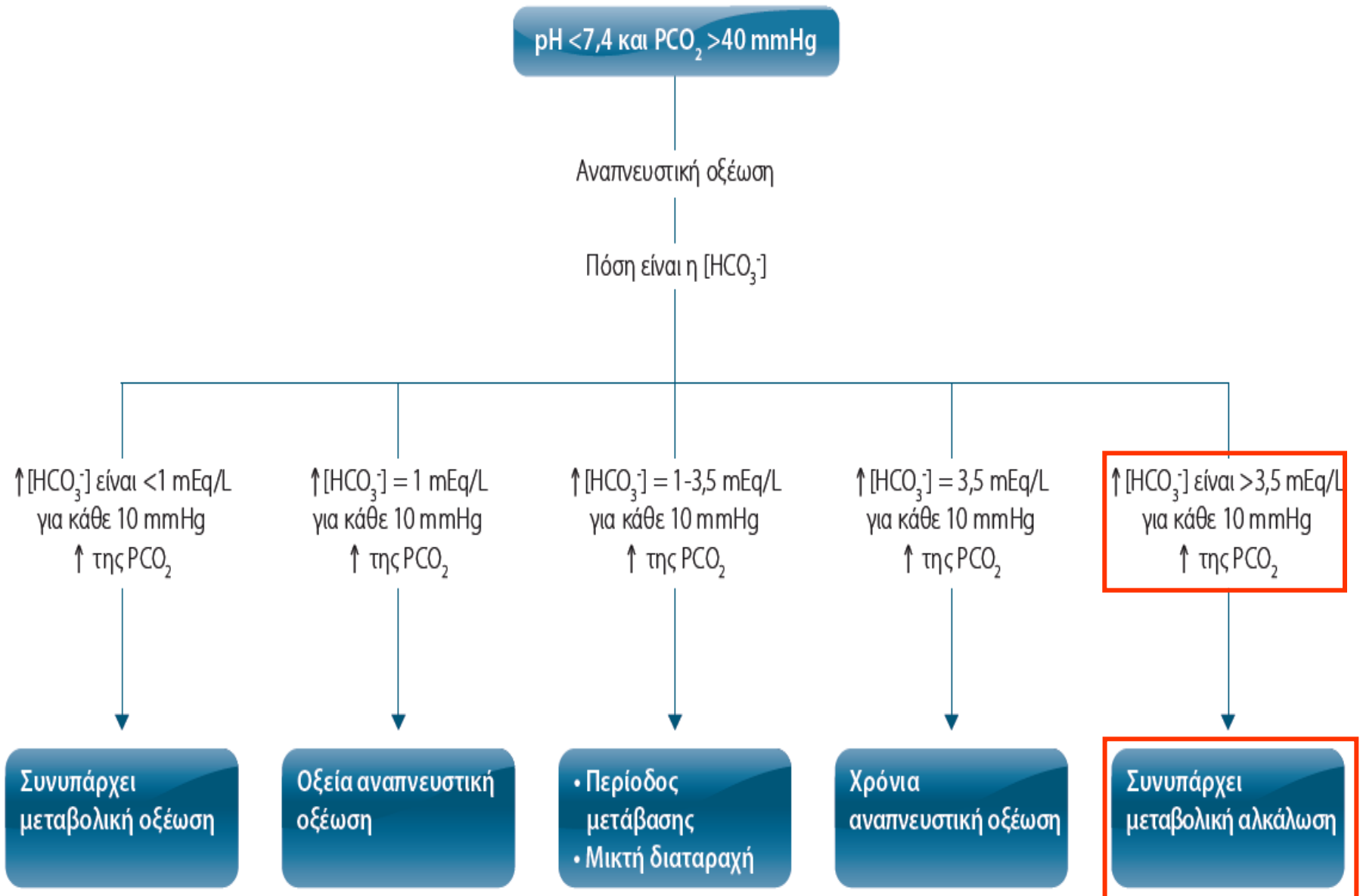
- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση

- pH = 7.38 (< 7.40)
- PCO<sub>2</sub> = 57 mmHg (> 40 mmHg)
- **Αναπνευστική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

# Η αναπνευστική οξέωση είναι οξεία ή χρόνια; Αμιγής ή συνυπάρχει μεταβολική διαταραχή;

- $[\text{HCO}_3^-] = 33 \text{ mEq/L}$  ,  $\uparrow$  κατά  $9 \text{ mEq/L}$
- $\text{PCO}_2 = 57 \text{ mmHg}$ ,  $\uparrow$  κατά  $17 \text{ mmHg}$
- Οξεία ΑΟ (;)  $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$  κατά  $1 \text{ mEq/L}$  για κάθε  $10 \text{ mmHg} \uparrow$  της  $\text{PCO}_2$ , δηλαδή  $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 1.7 = 25.7 \text{ mEq/L}$
- Χρόνια ΑΟ (;)  $\Rightarrow \uparrow [\text{HCO}_3^-]$  κατά  $3.5 \text{ mEq/L}$  για κάθε  $10 \text{ mmHg} \uparrow$  της  $\text{PCO}_2$ , δηλαδή  $[\text{HCO}_3^-] = 24 + 5.9 = 29.9 \text{ mEq/L}$
- $\uparrow [\text{HCO}_3^-] > 3.5 \text{ mEq/L}$  για κάθε  $10 \text{ mmHg} \uparrow$  της  $\text{PCO}_2$
- **Αναπνευστική οξέωση + Μεταβολική αλκάλωση**

## ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



## (A-a) DO<sub>2</sub>

- (A-a) DO<sub>2</sub> = [150 – 1.25 X (PCO<sub>2</sub>)] - PaO<sub>2</sub> = [150 – (1.25 X 57)] – 45 = 150 – 71.25 – 45 = 33.75 mmHg
- ↑ (A-a) DO<sub>2</sub> = πνευμονική νόσος (ΧΑΠ)

# Αναπνευστική οξέωση + Μεταβολική αλκάλωση

- Η μικτή διαταραχή αναπνευστικής οξέωσης και μεταβολικής αλκάλωσης είναι ιδιαίτερα συχνή στους ασθενείς με υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς οι περισσότεροι απ' αυτούς έχουν πνευμονική καρδιά (cor pulmonale) με παρουσία οιδημάτων (χρήση διουρητικών φαρμάκων)

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει αναπνευστική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση λόγω ΧΑΠ και πνευμονικής καρδίας (οιδήματα) και πιθανή χρήση διουρητικών φαρμάκων

# Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική αλκάλωση
- δ. Αναπνευστική οξέωση + μεταβολική οξέωση